UNIVERSIDAD DEL NORTE SANTO TOMÁS DE AQUINO (UNSTA)
Facultad de Ciencias de la Salud · Licenciatura en Nutrición · Ciclo Lectivo 2026
Cátedra de Nutrición Infantil · Docente a cargo: Lic. Germán

EVALUACIÓN PRÁCTICA
1° PARCIAL · PROTOCOLOS CLÍNICOS
Banco Oficial de Talleres de la Plataforma

Estudiante: _____	**Legajo / DNI:** _____
Comisión / Grupo: _____ **Fecha:** _____ / _____ / 2026	**Calificación Final:** _____ **/ 10 pts**

CONSIGNAS DE EVALUACIÓN: Marque con una cruz [X] la única opción correcta en cada ítem y vuelque su selección en la grilla inferior de control. Cada consigna respondida correctamente equivale a 2.0 puntos (Puntaje Máximo: 10 puntos).

1. [Taller de Preparación de Biberones · Seguridad Microbiológica] ¿Por qué las directrices internacionales (OMS/FAO) y de la cátedra exigen que el agua esté a aproximadamente 70 °C al momento de disolver la fórmula infantil en polvo?

- **[ ] A)** Porque a esa temperatura se disuelven mejor los carbohidratos y se previene que la preparación desarrolle sabor amargo.
- **[ ] B)** Porque las fórmulas en polvo no son estériles; el agua a ~70 °C actúa como tratamiento térmico bactericida que inactiva patógenos oportunistas letales como *Cronobacter sakazakii* y *Salmonella*.
- **[ ] C)** Porque temperaturas inferiores a 70 °C desnaturalizan las proteínas del suero lácteo e inactivan la biodisponibilidad de la lactoferrina agregada.
- **[ ] D)** Porque a 100 °C se altera la matriz plástica del biberón pero a 70 °C se maximiza la densidad calórica de las grasas lácteas.

2. [Taller de Preparación de Biberones · Osmolaridad y Fisiología Renal] Durante el armado del biberón, ¿por qué es mandatorio verter el agua caliente SIEMPRE ANTES que el polvo y qué riesgo pediátrico grave previene?

- **[ ] A)** Previene que los sólidos se aglutinen en la rosca del biberón e impidan el sellado hermético de la tetina de silicona.
- **[ ] B)** Si se coloca el polvo primero, el volumen ocupado por los sólidos desplaza solvente, generando una fórmula hiperconcentrada que expone al lactante a sobrecarga osmolar renal y deshidratación hipernatrémica grave.
- **[ ] C)** Verter el agua caliente antes permite la solubilización inicial del hierro iónico aumentando su coeficiente de absorción yeyunal.
- **[ ] D)** Evita que el agua a 70 °C hidrolice anticipadamente las micelas de caseína provocando meteorismo por sobrecarga de lactosa.

3. [Taller de Fórmulas Infantiles · Dosificación y Dilución Reglamentaria] Respecto a la técnica reglamentaria de dosificación y enrase del polvo: ¿Cuál es el procedimiento estandarizado y la relación de dilución establecida?

- **[ ] A)** Llenar la medida provista, compactar firmemente con el pulgar contra la lata y disolver a razón de 2 medidas por cada 50 ml de agua potable.
- **[ ] B)** Llenar el cacito en forma colmada y diluir 1 medida por cada 60 ml de agua para facilitar el vaciamiento gástrico en lactantes sanos.
- **[ ] C)** Llenar la cuchara medidora de la lata sin presionar ni apisonar, enrasar al ras con el reborde nivelador o el lomo de un cuchillo limpio, respetando la relación de 1 medida al ras cada 30 ml de agua potable.
- **[ ] D)** Pesar el polvo en balanza de cocina a razón de exactamente 15 g de polvo disueltos en 50 ml de agua a temperatura ambiente.

4. [Taller de Preparación de Biberones · Técnica de Homogeneización] ¿Por qué está expresamente contraindicado agitar la mamadera verticalmente con fuerza ('estilo coctelera') y cuál es la técnica indicada de reconstitución?

- **[ ] A)** Porque la agitación vigorosa descalibra la válvula anticólicos de silicona; debe homogeneizarse agitando exclusivamente con varilla estéril.
- **[ ] B)** Porque el batido vertical desnaturaliza los ácidos grasos poliinsaturados precipitando como cristales lipídicos insolubles.
- **[ ] C)** Porque la agitación vigorosa incorpora abundante aire en forma de microburbujas y espuma que provocan aerofagia severa, distensión y cólicos; debe mezclarse haciendo rodar suavemente el biberón entre las palmas de las manos.
- **[ ] D)** Porque la agitación vigorosa incrementa la presión hidrostática dentro del envase expulsando componentes termolábiles de la fórmula.

5. [Taller de Evaluación Antropométrica Gestacional · Curvas de Calvo et al. (2009)] ¿Cuál es la principal ventaja clínica de la Gráfica de Calvo et al. (2009) para el nutricionista durante la consulta prenatal?

- **[ ] A)** Permite calcular con precisión milimétrica la ganancia neta de tejido adiposo materno diferenciada del peso fetal y de la placenta.
- **[ ] B)** Permite formular un diagnóstico nutricional puntual en cualquier consulta prenatal (incluso en captaciones tardías del 2° o 3° trimestre) relacionando IMC materno y edad gestacional sin depender del peso pregestacional de la paciente.
- **[ ] C)** Reemplaza por completo el cálculo del Valor Calórico Total diario estableciendo incrementos fijos de 500 kcal/día por cada desvío estándar.
- **[ ] D)** Automatiza la detección de diabetes gestacional y prescribe los gramos de carbohidratos complejos según semanas de amenorrea.

Pregunta	1	2	3	4	5
Opción					

Firma del Estudiante: _____
Aclaración: _____

Firma Docente: _____
Puntaje Total Obtenido: _____ / 10 pts